3 Gesundheit im höheren Alter

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- haben Sie einen Überblick über verschiedene Begriffsbestimmungen und Klassifikationen des höheren Lebensalters sowie über den demographischen Wandel und seine Auswirkungen,
- kennen Sie die Bedeutung der subjektiven Gesundheit im höheren Alter und können das Altersinvarianz-Paradox erklären und Begründungen hierzu benennen,
- sind Ihnen ausgewählte Theorien und Befunde zur psychosozialen Anpassung im höheren Alter bekannt,
- besitzen Sie Kenntnisse über Ziele, Trends und Herausforderungen bei Gesundheitsförderungsmaßnahmen im höheren Alter,
- haben Sie sich mit zentralen physiologischen und psychischen Gesundheitsbelastungen des höheren Alters befasst und können präventive Maßnahmen hierzu benennen.

3.1 Höheres Alter

Die Bedingungen für Gesundheit und Krankheit werden unter anderem durch die Lebensphase beeinflusst, in der sich eine Person befindet. In Europa wächst der Bevölkerungsanteil an Menschen in einem höheren und hohen Lebensalter, und dementsprechend steigt der Bedarf an fundiertem Grundlagenwissen zur gesundheitlichen Situation in dieser Lebensphase und nach altersgruppengerechten gesundheitsfördernden und präventiven Maßnahmen.

3.1.1 Begriffsbestimmungen und Klassifikationsansätze des höheren Lebensalters

Das Konzept „höheres Lebensalter" ist nicht eindeutig definiert, sondern kann sich je nach Zielrichtung an verschiedenen Verständnissen von Alter ausrichten und unterschiedliche Einteilungen in Altersgruppen umfassen. Die wohl geläufigste Festlegung von Alter erfolgt anhand des kalendarischen beziehungsweise chronologischen Alters, also dem tatsächlichen Alter von der Geburt bis zum aktuellen Zeitpunkt in Lebensjahren. Es existieren jedoch auch weitere Begriffsbestimmungen, nämlich:

- *Physiologisches beziehungsweise biologisches Alter*. Dies beschreibt Alter aus medizinischer Sicht anhand des Fortschreitens der Degeneration der Zellen und des Vorliegens funktioneller Beeinträchtigungen sowie der Funktionsfähigkeit der Organe und des gesamten Körpers.
- *Soziales Alter*. Dabei handelt es sich um ein umstrittenes Konstrukt, bei dem zur Bestimmung des Alters Faktoren wie altersgerechtes Verhalten oder auch die Stellung in der Gesellschaft einbezogen werden.
- *Psychologisches beziehungsweise subjektives Alter*. Diesem Verständnis zufolge ist das gefühlte Alter ein zentrales Kriterium.

Neben diesen unterschiedlichen Schwerpunkten der Definitionen von Alter existieren auch unterschiedliche Vorschläge dazu, in welche Unterabschnitte das höhere Alter eingeteilt werden sollte. Eine geläufige Einteilung, die vor allem in der Gerontologie (d. h. der Wissenschaft vom Altern der Menschen) vorgenommen wird, unterscheidet das dritte und das vierte Lebensalter. Dabei wird der Beginn des dritten Lebensalters ab der Grenze von 60 oder 65 Jahren und der Beginn des vierten Lebensalters ab 80 oder 85 Jahren festgesetzt, wobei auch diese Grenzen eher als dynamisch zu betrachten sind. Tesch-Römer und Wurm (2009) fassen die Verwendung der Altersbegriffe wie folgt zusammen:

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

- Alter (alte Menschen, ältere Menschen): alle Personen ab 65 Jahren und älter,
- Drittes Lebensalter (junge Alte): alle Personen ab einem Alter von 65 bis 85 Jahren,
- Viertes Lebensalter (sehr alte Menschen, alte Alte, Hochaltrige, Hochbetagte): alle Personen ab 85 Jahren und darüber hinaus.

Die Festlegung des Beginns des höheren Alters ab 65 Jahren bezieht den Übergang in den beruflichen Ruhestand als definierendes Kriterium ein. Damit unterliegt diese Einteilung ebenso einer gewissen Dynamik, da sich der Eintritt ins Rentenalter durch die steigende Lebenserwartung kontinuierlich nach oben verschiebt. In Deutschland wird beispielsweise der Beginn des regulären Rentenalters (d. h. bei Eintritt Zahlung der Rente ohne Abschläge) seit 2012 stufenweise angehoben, so dass er bis zum Jahr 2029 mit 67 Jahren erfolgen wird. Bei der Orientierung am Renteneintrittsalter für die Festlegung der unteren Grenze des höheren Alters ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich dabei um einen von außen gesetzten Zeitpunkt in individuellen Biografien handelt und mit dem Ende der Erwerbstätigkeit nicht zwangsläufig jene Arten von Altersprozessen einsetzen, die die Ausübung einer Tätigkeit verhindern (Petermann & Roth, 2006).

Um die Bedeutsamkeit einer Abgrenzung der verschiedenen Lebensabschnitte im höheren Alter zu unterstreichen, haben P. B. Baltes und Smith (2003) auf Grundlage gerontologischer Forschungsergebnisse die jeweils wichtigsten Entwicklungen des dritten und vierten Lebensabschnitts zusammengefasst (siehe Tabelle 3.1). Sie charakterisieren dabei die Erkenntnisse zum dritten Lebensabschnitt als „Die guten Neuigkeiten" (engl.: the good news) und die zum vierten Lebensabschnitt als „Die nicht so guten oder schlechten Neuigkeiten" (engl.: the not-so-good or bad news).

Tabelle 3.1

Wesentliche Merkmale des dritten und vierten Lebensalters

Drittes Lebensalter	Viertes Lebensalter
▪ Die Lebenserwartung steigt: Mehr Ältere Menschen leben länger. ▪ Substanzielles Potential für bessere physische und mentale Fitness im Alter ▪ Kohorten zeigen über die Generationen eine sukzessive Verbesserung physischer und mentaler Fitness ▪ Immer mehr Personen altern erfolgreich ▪ Hohes Ausmaß an emotionalem und persönlichem Wohlbefinden ▪ Effektive Strategien, um mit den Gewinnen und Verlusten im späteren Leben umzugehen	▪ Merkbare Verluste des kognitiven Potentials und der Lernfähigkeit ▪ Erhöhung des chronischen Stresses ▪ Merkbare Prävalenz demenzieller Erkrankungen (ca. 50 % der 90-Jährigen) ▪ Ein hohes Ausmaß an Gebrechlichkeit, Dysfunktionalität und Multimorbidität ▪ Sterben im höheren Alter: Mit menschlicher Würde?

Anmerkung. NachP. B. Baltes & Smith, 2003, S. 125.

3.1.2 Demographischer Wandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung

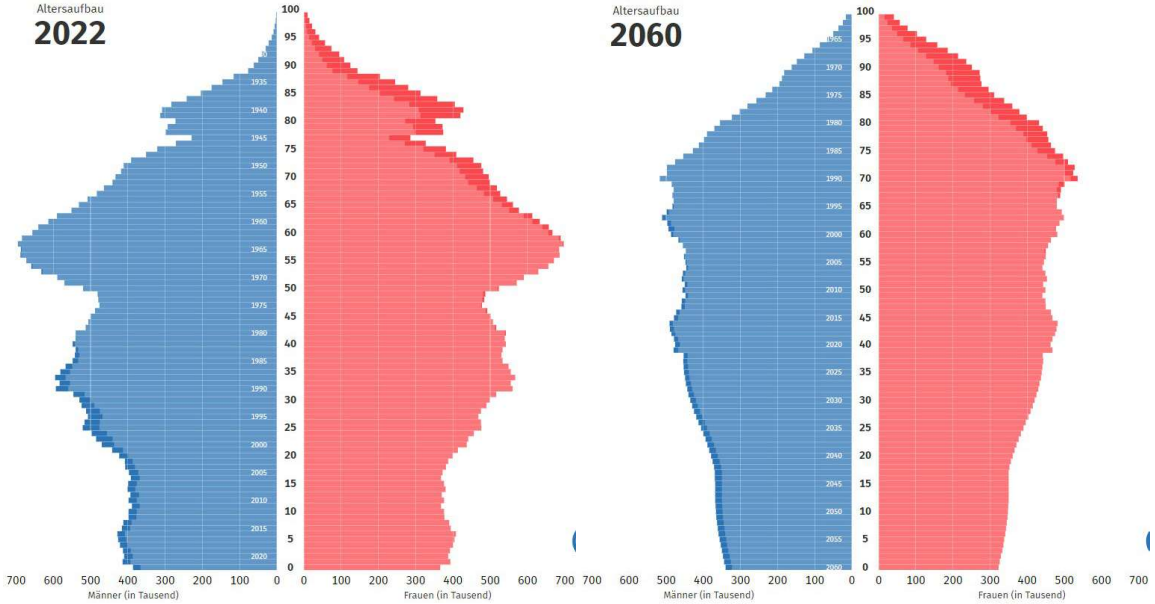
In den letzten Jahrzehnten ist die durchschnittliche Lebenserwartung vor allem in den westlichen Industrieländern kontinuierlich gestiegen. Hatte ein 1910 geborenes Mädchen noch eine Lebenserwartung von 51 Jahren, ist diese rund 100 Jahre später auf 82 Jahre gestiegen (Statistisches Bundesamt, 2012). Auch bedingt durch die gleichzeitig rückläufige Geburtenrate wird sich die altersbezogene Zusammensetzung der Bevölkerung in den kommenden Jahren daher

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

deutlich verändern. Während 2014 insgesamt 27 % der deutschen Bevölkerung ein Mindestalter von 60 Jahren aufwies, werden es 2030 voraussichtlich 36 % und 2050 schätzungsweise knapp 40 % der Bevölkerung sein. Auch die Zahl der Hochbetagten (in diesem Fall definiert als über 80-jährige Personen) wird sich vermutlich von 4.5 Millionen im Jahr 2014 auf knapp 10 Millionen im Jahr 2050 verdoppeln (Statistisches Bundesamt, 2016). Abbildung 3.1 zeigt die Altersstruktur in der Bevölkerung im Jahr 2008 und kontrastiert diese mit der geschätzten Struktur im Jahre 2060 (Statistisches Bundesamt, 2012). Eine animierte Alterspyramide finden Sie unter https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/ (Statistisches Bundesamt, 2024).

Abbildung 3.1

(Prognostizierte) Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland 2022 und 2060 (Statistisches Bundesamt, 2024).



Die demographische Entwicklung hat dabei erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung. So dauert ein Krankenhausaufenthalt einer über 65-jährigen Person durchschnittlich 2.4 Tage länger als der einer unter 65-jährigen. Auch weist die Gruppe der über 65-Jährigen doppelt so viele Krankenhausaufenthalte wie die Gruppe der 45- bis 65-Jährigen auf. Bezogen auf die bundesweiten Krankheitskosten sind die der 65- bis 84-Jährigen im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung doppelt so hoch, während sie ab dem 85. Lebensjahr bis auf das Fünffache ansteigen (Statistisches Bundesamt, 2012). Dabei stellt die aufgrund des demographischen Wandels der Alterung immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen den gesundheitsbezogenen Ausgaben auf der einen Seiten und den Einnahmen durch die Beitragszahlungen auf der anderen Seite ein gravierendes Problem der gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland dar (Böhm & Mardorf, 2009).

3.2 Theorien zur erfolgreichen psychosozialen Anpassung im Alter

Während lange Zeit in der gerontologischen Forschung eine eher defizitorientierte Sicht auf das Alter vorherrschte, werden heute zunehmend Indikatoren, Voraussetzungen und Konsequenzen eines erfolgreichen Alterns (engl. successful aging) in den Blick genommen (Levenson & Aldwin, 1994). Eine allgemeine Definition erfolgreichen Alterns hat sich dabei bis heute jedoch nicht durchgesetzt. Das Spektrum erstreckt sich über Auffassungen, die sich auf die Abwesenheit altersbezogener Defizite (z. B. Verlust des Funktionsniveaus) beziehen(Dittmann-

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Kohli, 1989), bis hin zu einem Verständnis des erfolgreichen Alterns als gelungene Adaption einer Person an die biologischen, psychologischen und sozialen altersbedingten Veränderungen (P. B. Baltes & Baltes, 1990).

Das *Modell des erfolgreichen Alterns* von Rowe und Kahn (1997)unterscheidet normales Altern (hier wird eher Krankheitsfreiheit, aber ein hoher Risikostatus angenommen) und erfolgreiches Altern. Erfolgreiches Altern weist dabei im Vergleich zum normalen Altern folgende drei Merkmale auf:

- eine geringe Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen oder krankheitsbedingte Behinderung,
- ein hohes kognitives und physisches Funktionsniveau,
- ein aktives Engagement im alltäglichen Leben.

Diese drei Merkmale bedingen sich wechselseitig und betonen neben der Krankheitsfreiheit besonders die aktive Beteiligung am Leben als Kennzeichen des erfolgreichen Alterns.

Kritisch ist anzumerken, dass das Konzept eine mögliche Diskrepanz zwischen der subjektiven Einschätzung einer Person hinsichtlich ihres erfolgreichen Alterns bei gleichzeitiger objektiver Nichterfüllung der Kriterien nach Rowe und Kahn (1997)nicht berücksichtigt. Ein anderer Kritikpunkt an dem Modell besteht darin, dass der prozesshafte Charakter des Alterns nicht ausreichend berücksichtigt wird (Wettstein & Wahl, 2018).

3.2.1 Die Aktivitäts-, die Disengagement- und die Kontinuitätstheorie

Zur Beschreibung und Erklärung der Prozesse, die ein erfolgreiches Altern begünstigen, wurde eine Reihe von theoretischen Ansätzen mit jeweils etwas unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen formuliert.

Die *Aktivitätstheorie* (Havighurst et al., 1963) geht davon aus, dass ein Abbau von psychischen und physischen Fähigkeiten durch einen Mangel an Beschäftigung ausgelöst wird. Zur Vermeidung solcher negativen Entwicklungen sollten ältere Menschen daher neue Rollen einnehmen, wie zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeiten oder vermehrte Hilfe bei der Unterstützung der nachfolgenden Generationen, um so aktiv zu bleiben. Gestützt werden diese Annahmen durch negative Zusammenhänge zwischen (einer Zunahme von) sozialem Rückzug und einer Abnahme des Gefühls, gebraucht zu werden.

Eine andere Theorie in diesem Kontext ist die *Disengagementtheorie* (Cumming & Henry, 1961). Sie postuliert, anders als die Aktivitätstheorie, dass im höheren Alter ein allgemeiner, schrittweise vollzogener Rückzug aus sozialen und gesellschaftlichen Positionen eine normale und förderliche Entwicklung darstellt. Dabei wird ein gegenseitiger Rückzug angenommen: einerseits zieht sich die Gesellschaft, andererseits das Individuum zurück. Somit soll in der Gesellschaft Raum für die folgenden Generationen geschaffen werden, während sich die alten Menschen auf den nahenden Tod vorbereiten können. Inkongruenzen sollen nach diesem Ansatz dann entstehen, wenn das Bedürfnis nach Rückzug von anderer Seite (z. B. durch die Angehörigen) nicht respektiert wird. Dabei gehen Cumming und Henry (1961) jedoch nicht von einem absoluten Rückzug aus, sondern betonen vielmehr die Notwendigkeit der Ausgestaltung altersgerechter Rollen (z. B. in Ehrenämtern), um die abnehmende Zahl sozialer Kontakte zu kompensieren.

Die *Kontinuitätstheorie* von Atchley (1989) wiederum beruht auf der Annahme, dass eine zufriedenstellende Gestaltung des höheren Lebensalters am besten gelingt, wenn eine gewisse Stabilität gewährleistet ist. Diese umfasst sowohl die Kontinuität innerer Bedingungen (z. B. Erhalt von Einstellungen, Verhaltensweisen, Vorlieben) als auch äußerer Bedingungen (d. h. der materiellen und sozialen Umwelt, mit der der Mensch im Austausch steht). Dabei berücksichtigt diese Theorie in sehr starkem Maße die Individualität der älteren Personen. So soll es für kontaktscheuere Menschen förderlicher sein, im Alter weiterhin zurückgezogen zu leben,

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

während sehr aktive Menschen auch im höheren Alter eine starke soziale Einbindung benötigen würden.

Während einige Studienergebnisse die generell positiven Wirkungen eines auch im Alter aktiven Lebens betonen (Maddox, 1965), scheint die Berücksichtigung der individuellen Vorlieben und Gewohnheiten, wie sie in der Kontinuitätstheorie beschrieben wird, ebenso bedeutsam für den Erhalt der Lebensqualität (Olbrich & Lehr, 1976) zu sein. Jedoch sind auch die Annahmen der Kontinuitätstheorie dahingehend kritisiert worden, dass sie eine mögliche Verbesserung des Befindens im höheren Alter gerade durch Veränderungen und Neuorientierungen nicht erklärt.

3.2.2 Das SOK-Modell

Das Modell der „Selektiven Optimierung mit Kompensation" (SOK-Modell) wurde von P. B. Baltes und Baltes (1990)vorgeschlagen und ist eine der einflussreichsten theoretischen Konzeptionen in der Psychogerontologie.

Um dem Abbau der körperlichen und geistigen Fitness und allgemein Ressourcenverlusten entgegenzuwirken, können drei unterschiedliche Strategien genutzt werden, die zur Erhaltung des eigenen Wohlbefindens dienlich sind: Selektion, Optimierung und Kompensation. *Selektion* umfasst dabei die Konzentration auf die zentralen Ressourcen und Funktionsbereiche, während weniger wichtige Aspekte außer Acht gelassen werden sollen. *Optimierung* bezieht sich auf die Verbesserung beziehungsweise das Training eben dieser Bereiche. *Kompensation* soll den Rückgang der anderen Funktionsbereiche ausgleichen, indem gezielt vorhandene Ressourcen vermehrt oder in neuen Bereichen eingesetzt werden. Insbesondere durch die Orchestrierung dieser drei Strategien soll eine erfolgreiche Anpassung im höheren Alter ermöglicht werden (siehe Beispiel in Kasten 3.1).

Frau W. hat ihr Leben lang ihren großen Garten gepflegt und Gartenarbeit verrichtet. Dies fällt ihr nun im höheren Alter zunehmend schwerer. Um ihrer Leidenschaft jedoch weiter nachgehen zu können, beschließt sie, sich nur noch um die Beete selbstständig zu kümmern (Selektion), während sie für die Pflege der Sträucher, Bäume und des Rasens Unterstützung organisiert (Kompensation). Im Winter versucht Frau W., durch Dehn- und Kräftigungsübungen für den Rücken ihre Fitness zu verbessern und sich so gezielt auf die Pflege der Beete vorzubereiten (Optimierung). Zudem erwirbt Frau W. hochwertigere Geräte für die Gartenarbeit, wodurch sie weniger Kraft bei den einzelnen Tätigkeiten aufwenden muss (Kompensation).

Kasten 3.1. Beispiel für das Zusammenwirken von Optimierung, Kompensation und Selektion.

Ältere Personen, die diese Strategien zur Adaption an das Alter nutzen, weisen höhere Werte bei verschiedenen Indikatoren erfolgreichen Alterns auf (z. B. mehr subjektives Wohlbefinden, mehr positive Emotionen und weniger Einsamkeit; Freund & Baltes, 1998). Anzumerken ist dabei jedoch, dass die Strategien der Selektion, Kompensation und Optimierung insbesondere von denjenigen älteren Personen genutzt werden, die bereits mit zahlreichen Ressourcen ins höhere Lebensalter eingetreten sind (Lang et al., 2002).

3.3 Subjektive Gesundheit im höheren Alter

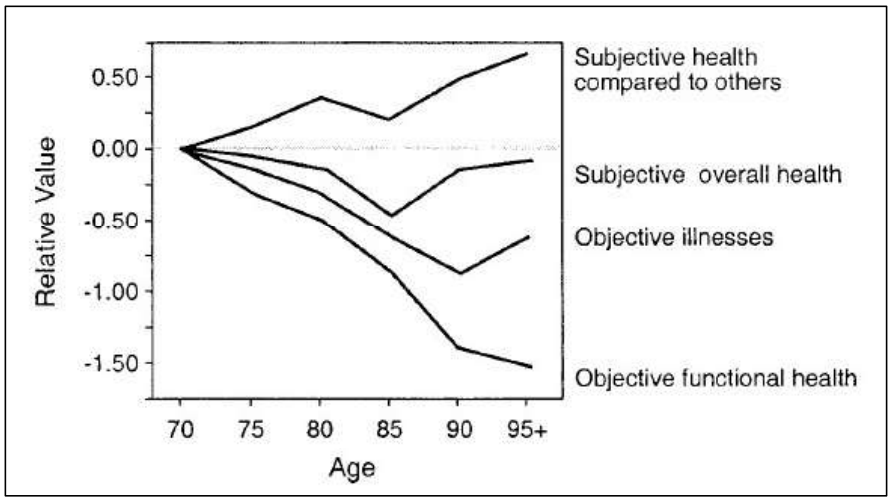
Die subjektive Gesundheit, also die Bewertung des Gesundheitszustands durch die Person selbst, nimmt im höheren Alter eine besondere Stellung ein. Da sich der medizinisch diagnostizierte Zustand (also die objektive Gesundheit) mit steigendem Alter in der Regel deutlich verschlechtert, könnte angenommen werden, dass ältere Personen Ihre Gesundheit

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

dementsprechend negativer einschätzen. Jedoch scheint dieser plausible Zusammenhang zwischen subjektiver und objektiver Gesundheit eher moderat auszufallen. Bei einer Befragung von EU-Bürger:innen des Statistischen Bundesamts (2016) schätzte beispielsweise mehr als die Hälfte der 65- bis 74-Jährigen ihren gesundheitlichen Status als gut oder sogar sehr gut ein. Dies korrelierte positiv mit dem Einkommen und Bildungsstand. Der Effekt tritt zudem besonders stark bei Personen im höheren Alter auf; bei ihnen stimmen die subjektive Gesundheitseinschätzung und der objektive Gesundheitszustand am wenigsten überein (Wurm & Tesch-Römer, 2006). Interessanterweise scheint die Bewertung der subjektiven Gesundheit dabei insgesamt recht stabil zu sein. Dies zeigen die Daten der Berliner Altersstudie (BASE-Studie), die über 500 Menschen zwischen 70 und 100 Jahren in den 90er Jahren unter anderem hinsichtlich verschiedener Gesundheitsparameter untersuchte. In Abbildung 3.2 sind die Verläufe der subjektiven Gesundheit (allgemein und im Vergleich zu anderen) und des objektiven Krankheitszustands sowie des objektiven Funktionsniveaus über das Alter zu sehen.

Abbildung 3.2

Daten der BASE-Studie zur Diskrepanz zwischen der subjektiven Gesundheitseinschätzung und dem objektiven Gesundheitszustand. Aus P. B. Baltes & Smith, 2003, S.127



Die Verläufe zeigen auf, dass die objektive Gesundheit immer weiter abnimmt, während die subjektive Gesundheit bis ins hohe Alter als positiv bewertet wird. Dies führt dazu, dass insbesondere im sehr hohen Alter eine hohe Diskrepanz zwischen subjektiver und objektiver Gesundheit zu finden ist. Dieser Befund wird auch als „Altersinvarianz-Paradox", „Wohlbefindens-Paradox" oder „Zufriedenheits-Paradox" bezeichnet (siehe auch Kurs 3, Kapitel 6 „Pflege und Gesundheit"). Wettstein und Wahl (2018) ziehen hierfür unterschiedliche Erklärungsmechanismen in Betracht:

- *Soziale Vergleichsprozesse*. Insbesondere Personen im sehr hohen Alter orientieren sich vorwiegend an Gleichalterigen mit einer schlechteren Gesundheit.
- *Response shift*. Die schwindende Gesundheit wird zwar wahrgenommen, jedoch als normativ und altersentsprechend betrachtet. Die Einschätzung der eigenen Gesundheit berücksichtigt dabei auch, dass der Gesundheitszustand noch schlechter sein könnte.
- *Age-related positivity effect*. Es konnte vielfach nachgewiesen werden, dass ältere Personen viel stärker als jüngere Personen ihre Aufmerksamkeit eher auf positive als auf negative Dinge richten. Bezogen auf den Gesundheitszustand bedeutet dies, dass ältere Personen in ihrer Wahrnehmung vermehrt positive Aspekte hervorheben („Ich kann noch gut laufen") und negativen weniger Beachtung schenken („Ich kann schlechter sehen").

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Die subjektive Gesundheit ist im höheren Alter vor allem auch deshalb eine wichtige Einflussgröße, weil sie ein Indikator für das Gesundheitsverhalten und die tatsächliche Lebensdauer ist. Schreiben ältere Menschen ihre gesundheitlichen Beschwerden eher ihrem Alter zu, dann zeigen sie im Allgemeinen ein schlechteres Gesundheitsverhalten (z. B. selteneres Aufsuchen von medizinischen Einrichtungen) als gleichalterige Menschen, die ihre Beschwerden als krankheitsbedingt ansehen (Goodwin et al., 1999). Auch der Einfluss der subjektiven Gesundheit auf die Lebensdauer konnte in verschiedenen Studien nachgewiesen werden. So sagt die subjektiv eingeschätzte Gesundheit die Lebensdauer besser vorher als der durch medizinisches Fachpersonal diagnostizierte objektive Gesundheitszustand (Idler & Benyamini, 1997; Lehr, 1997). Wurm et al. (2009) ziehen zwei übergeordnete Erklärungsansätze für die hohe Bedeutsamkeit der subjektiven Gesundheit und ihrer Vorhersagekraft in Betracht. Ein Erklärungsansatz verweist auf die Grenzen der medizinischen Messbarkeit. Insbesondere subtile physiologische Veränderungen können in der subjektiven Einschätzung bemerkt werden, aber objektiven diagnostischen Messungen entgehen. Der andere Erklärungsansatz verweist auf den subjektiven Gesundheitszustand als psychosoziale Ressource. Dabei kann die subjektive Gesundheitseinschätzung einen direkten Effekt auf die Gesundheit haben (zum Beispiel die positiven Gefühle bei optimistischer Einschätzung) oder einen indirekten Effekt über das Gesundheitsverhalten (z. B. Alkoholkonsum, um die negativen Emotionen zu regulieren, die durch die pessimistische Einschätzung hervorgerufen wurden). Insgesamt kann festgehalten werden, dass die subjektive Gesundheit eine wichtige Determinante der Gesundheit im höheren Alter darstellt.

3.4 Gesundheitsförderung im höheren Alter

Der demographische Wandel macht Prävention und Gesundheitsförderung (siehe Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention“) im höheren Alter zu immer wichtigeren Themen. Aufgrund der Charakteristika dieser Lebensphase besteht dabei zunächst auch die Notwendigkeit zu prüfen, welches Verständnis von Gesundheit im Kontext von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im höheren Alter angemessen ist. Eine sehr umfassende Gegenstandsbestimmung der Gesundheit im Alter als Orientierung für Maßnahmen der Gesundheitsförderung stammt von Kruse (2018) und umfasst fünf Dimensionen:

1. Das Fehlen von Krankheiten und Krankheitssymptomen,
2. ein optimaler funktionaler Status,
3. eine aktive, selbstverantwortliche, persönlich zufrieden stellende Lebensgestaltung,
4. eine gelingende Bewältigung von Belastungen und Krisen,
5. ein individuell angemessenes System medizinisch-pflegerischer und sozialer Unterstützung.

Eine besondere Rolle bei der Gesundheitsförderung für Menschen mit höherem Alter kommt dabei den Kommunen und Gemeinden zu, da die Lebensumstände vor Ort wichtige Einflussgrößen für die Gesundheit und Krankheit in dieser Gruppe sind. Zentrale Aufgabenfelder der Kommunen und Gemeinden bestehen darin, die stationäre Gesundheitsversorgung zu stärken und integrierte Handlungskonzepte bereitzustellen. Anhand ganzheitlicher Programme, die insbesondere gesunde Ernährung, Bewegung und die Stärkung des sozialen Umfeldes ansprechen, sollen Menschen länger gesund bleiben und eigenständig zu Hause alt werden können (Altgeld, 2009). In einer Bestandsaufnahme zur seniorenbezogenen Gesundheitsförderung von Hollbach-Grömig und Seidel-Schulze (2007) gaben die meisten Kommunen an, dass sie folgende Angebote für Menschen im höheren Alter bereitstellen: Wohnberatung, Angebote für Sport und Bewegung, Kurse zur Verbesserung der

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Gedächtnisleistung, Beratung bezüglich risikobezogener Maßnahmen, Maßnahmen zur Stärkung des Pflegepotentials, aufsuchende Sozialarbeit, Ernährungskurse und Angebote zur Stärkung der Gesundheit pflegender Angehöriger (siehe Kurs 3, Kapitel 6 „Pflege und Gesundheit"). Jedoch ergab die Bestandsaufnahme ebenfalls, dass die Angebote bestimmte Gruppen älterer Personen nicht erreichen. Hierzu gehören insbesondere ältere Menschen mit niedrigem Bildungsniveau und niedrigem sozialen Status, ältere Menschen mit Migrationshintergrund, alleinstehende ältere Menschen, die über nur wenige Sozialkontakte verfügen, und auch ältere Menschen mit Behinderungen. Daher ist es ein weiteres wichtiges Ziel von Gesundheitsförderung im Alter, diese für alle Gruppen erreichbar zu machen. Eine Initiative, die die Erreichbarkeit von Angeboten durch die Vernetzung kommunaler Institutionen erhöhen will, ist das Projekt Aktiv55plus (http://www.aktiv55plus.de; siehe Kasten 3.2).

Das Projekt Aktiv55plus wurde Anfang der 2000er Jahre in Radevormwald initiiert, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen mit knapp 26,000 Einwohner:innen. In dieser Stadt war zu Beginn des Projekts mehr als ein Viertel der Einwohner:innen mindestens 60 Jahre alt, so dass ein deutlicher Bedarf an gesundheitsfördernden Maßnahmen für Personen im höheren Alter bestand. Bereits vor der Implementierung des Projekts waren in Radevormwald verschiedene Strukturen auf kommunaler Ebene gut vernetzt; im Rahmen des Projekts wurde dies noch verstärkt, indem sich freie Träger, die Stadt Radevormwald und das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises, Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen, Senioreneinrichtungen und Verbände aus Kultur und Sport zusammenschlossen. Für die Projektdurchführung wurde eine lokale Arbeitsgruppe gegründet. Das Projekt basiert auf den Grundannahmen, dass einerseits viele Angebote für ältere Personen auf kommunaler Ebene schon existieren und andererseits vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten bei älteren Personen bisher ungenutzt geblieben waren. Ziel des Projekts war es daher, den Zugang zu Angeboten zu erleichtern sowie die persönlichen Ressourcen weiter zu stärken. Das Projekt richtete sich dabei vor allem an ältere Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre aus dem Erwerbsleben ausgeschieden waren oder in den letzten fünf Jahren ihren/ihre Lebenspartner:in verloren hatten. Um einen Kontakt zu den potenziellen Teilnehmenden herzustellen, wurde die Zielgruppe angeschrieben und bei positiver Rückmeldung von einer Beraterin (im Projekt als „Anwältin" bezeichnet) besucht. Es wurden ungefähr 4,000 Personen angeschrieben, von denen letztlich knapp 350 Personen teilnahmen. Bei einem 60- bis 90-minütigen Erstgespräch wurde der Gesundheitszustand und die Lebenssituation von den Anwältinnen dokumentiert. Weiter wurden während der folgenden Besuchstermine Zielvereinbarungen für neue Aktivitäten und Verbesserungen der Gesundheit vereinbart. Diese wurden, wenn möglich, schriftlich festgehalten. Zudem wurde besprochen, welche Barrieren den Zielvereinbarungen möglicherweise im Wege stehen (z. B. Angst vor neuen Gruppen) und wie diese überwunden werden können. Pro teilnehmender Person wurden mindestens drei und bis zu acht Besuche in individuellen Abständen vereinbart. Ein weiteres wichtiges Ziel bestand aus der durch die Anwältinnen initiierten Vernetzung der Teilnehmenden. Diese erleichterte zum Beispiel das Einbringen eigener Vorschläge für verschiedene Gruppenaktivitäten, was zur Folge hatte, dass sich zahlreiche Teilnehmende über das Projektende hinaus in verschiedenen Gruppen weiter trafen. Ebenso wurde auf kommunaler Ebene daran gearbeitet, Barrieren, die sich während des Projekts identifizieren ließen, zu beseitigen. Zwar liegen keine objektiven Daten zur Verbesserung des Gesundheitszustands der Teilnehmenden vor, doch eine Abschlussbefragung unter den teilnehmenden und durchführenden Personen ergab, dass das Projekt insgesamt als erfolgreich beurteilt wurde. Nach Beendigung des ursprünglichen Projekts wurde daher ein Trägerverein

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

gegründet, der die verschiedenen Angebote in Radevormwald weiter koordiniert und zusammenstellt (World Health Organization [WHO], 2005).

Kasten 3.2. Das Gesundheitsförderungsprojekt aktiv55plus.

Viele bestehende Programme zur Gesundheitsförderung, die für die Allgemeinbevölkerung entwickelt wurden, sind auch für ältere Personen förderlich, werden jedoch aufgrund von Barrieren von dieser Personengruppe weniger genutzt. Daher schlagen Lippke und Kuhlmann (2013) vor, einzelne Charakteristika bestehender Gesundheitsförderungsprogramme für Menschen im höheren Alter umzugestalten. So wünschen sich ältere Personen beispielsweise, verständlichere Programme und weniger Durchführungsaufwand (Doh, 2012). Lippke und Kuhlmann (2013) schlagen eine Reihe von Maßnahmen zur altersgerechten Anpassung von Programmen vor. Dazu gehört eine Verringerung des Zeitumfangs, die Reduktion der Teilnehmerzahl innerhalb der Angebote, die Verbesserung der Lesbarkeit bei gedruckten Materialien, die Vereinfachung von Materialien, die Berücksichtigung altersspezifischer körperlicher Aspekte (z. B. keine weiten Anfahrtszeiten) oder der Einbezug personaler Ressourcen (z. B. die Familie). Insbesondere die Berücksichtigung persönlicher Kontakte und das Maßschneidern der Maßnahmen (siehe Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle“) scheinen für ältere Teilnehmende förderlich zu sein.

Eine andere Entwicklung, die für die Gesundheitsförderung im höheren Alter in den kommenden Jahren noch stärker als bisher relevant sein wird, ist der Fortschritt bei Medien und Technologien (Lippke & Kuhlmann, 2013). So sind neue Techniken und Medien in der Lage, durch Hausnotrufsysteme, Hörgeräte, unterstützende Technik im Haushalt (wie automatische Rollläden) oder Technologien zur Überwachung von Vitalfunktionen einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsförderung zu leisten (siehe Video 3.1 und Kurs 2, Kapitel 6 „eHealth“).

Video 3.1. Home sensors enable seniors to live independently (National Science Foundation News). Verfügbar unter https://youtu.be/NCixWY3eaOc

3.5 Krankheitsbelastungen des höheren Alters und Präventionsmaßnahmen

Die unvermeidlichen physiologischen Altersprozesse erhöhen die Anfälligkeit von Menschen für Krankheiten. Mit dem Alter nimmt die *Multimorbidität* zu, das heißt das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Krankheiten zur selben Zeit bei einer Person. Einbußen der Sensorik, wie Hör- und Sehbeeinträchtigungen, gehören ebenfalls zu den typischen chronischen Beeinträchtigungen des höheren Alters (Wettstein & Wahl, 2018). Zudem haben weitere Faktoren einen Einfluss auf die Gesundheit in dieser Lebensphase, wie das allgemeine Gesundheitsverhalten, soziale Ungleichheit sowie medizinische oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen (Tesch-Römer & Wurm, 2009). Ein wichtiges Charakteristikum für Erkrankungen bei Menschen im höheren Alter ist der tatsächliche Altersbezug. Beschwerden und Erkrankungen können maßgeblich altersbedingt sein (z. B. Knorpelschwund) oder aber unabhängig vom Lebensalter auftreten (z. B. Infekte); allerdings ist diese Unterscheidung nicht immer einfach zu treffen (z. B. bei Rückenschmerzen). Auch psychische Belastungen nehmen im Alter zu, während sich gleichzeitig die Stressverarbeitung auf physiologischer Ebene verschlechtert (Anisman, 2014). Psychische Belastungen stehen somit in einer reziproken Beziehung zur physischen Gesundheit im höheren Alter.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

3.5.1 Spezifische körperliche Gesundheitsbelastungen des höheren Alters

Die physiologischen Alternsprozesse begünstigen vielfältige Arten gesundheitlicher Belastungen. Ding-Greiner und Lang (2004) teilen diese gesundheitsbezogenen Alternsprozesse in drei Gruppen ein:

- Erscheinungen, die mit dem Alter korreliert sind, aber auch in anderen Altersgruppen auftreten können (z. B. arteriosklerotisch bedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen),
- Zunahme der Inzidenz spezifischer altersbedingter Krankheiten (z. B. Demenz),
- Störungen, die im jungen Alter keine ernsthafte Konsequenz haben, bei älteren Personen jedoch schon (z. B. Knochenbrüche).

Die Unterscheidung von Ding-Greiner und Lang (2004) ist insofern relevant, als dass sich hieraus verschiedenartig gestaltete Präventionsmaßnahmen ableiten lassen. Im Allgemeinen ist es bei der Prävention von Krankheiten im höheren Alter wichtig, die prinzipielle Beeinflussbarkeit alterskorrelierter Krankheitsprozesse (etwa bei einigen Formen demenzieller Erkrankungen) oder ihre Unveränderbarkeit (z. B. bei Hörverlust) bei der Planung von Präventionsmaßnahmen einzubeziehen. Sind die Prozesse beeinflussbar, sollten entsprechende Interventionen auf Prävention ausgerichtet sein (beispielsweise Training kognitiver Fertigkeiten). Sind hingegen alterskorrelierte Gesundheitseinbußen nicht mehr veränderbar, sollten Interventionen stärker auf den alltagspraktischen Umgang mit diesen Einbußen ausgerichtet sein, um die Funktionsausfälle zu kompensieren (z. B. die Anpassung eines Hörgeräts; Tesch-Römer & Wurm, 2009). Bezogen auf explizit gesundheitsfördernde (im Unterschied zu präventiven) Interventionen hat sich gezeigt, dass die weitere Stärkung einer schon vor Eintritt in das höhere Lebensalter praktizierten gesunden Lebensweise besonders positive Auswirkungen hat. Es sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass auch späte Verhaltensänderungen protektive oder kompensatorische Effekte zeigen (Renner & Staudinger, 2008).

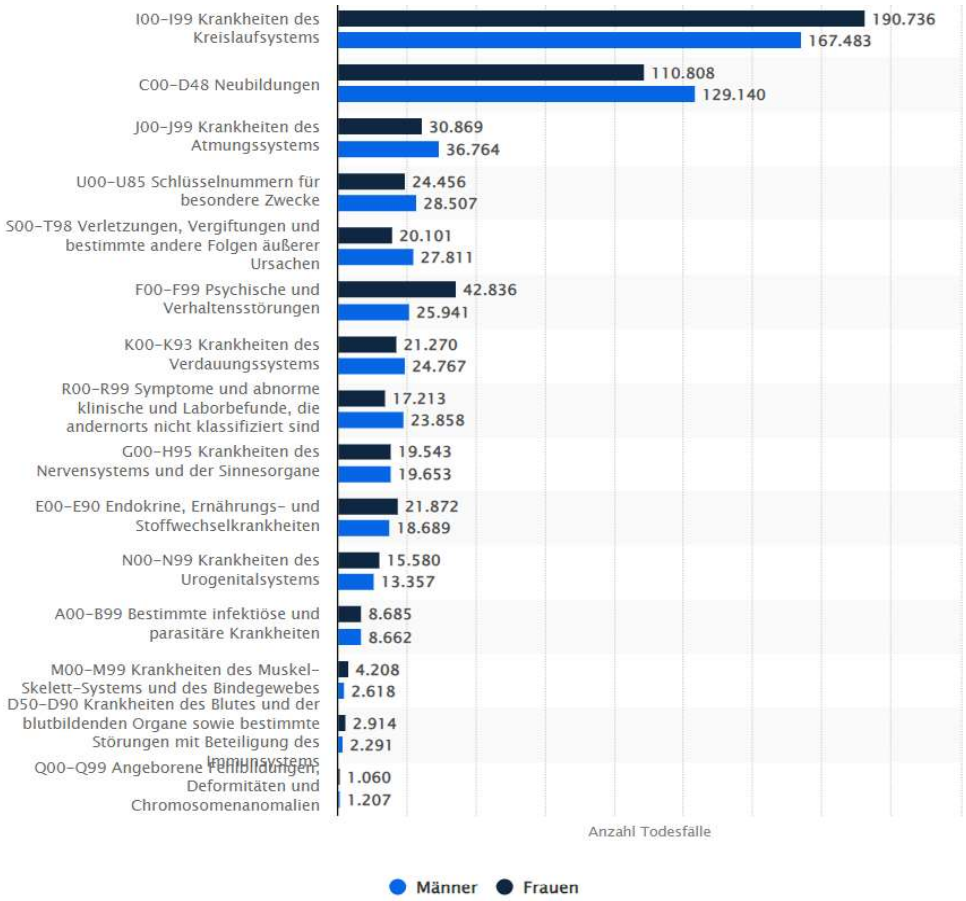
Herz-Kreislauf-Erkrankung

Herz-Kreislauf-Erkrankungen umfassen sämtliche Krankheiten des Herzens und des Blutkreislaufs. Häufig entstehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgrund von Arteriosklerose (Gefäßablagerungen in den Arterien). Diese Ablagerungen können zu einer Gefäßverengung und damit zu Durchblutungsstörungen führen. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass die Ablagerungen aufbrechen und sich Thromben bilden, die zu einem kompletten Verschluss der Gefäße führen können. In beiden Fällen kann die Folge eine Minderdurchblutung des Herzens sein oder auch zum Absterben großer Teile des Herzmuskels (Herzinfarkt, Myokardinfarkt) führen (Vögele, 2016). Tritt diese Minderdurchblutung des Herzmuskels aufgrund der Verengung der Herzkranzgefäße auf, spricht man auch von chronischer ischämischer Herzkrankheit (oft als koronare Herzkrankheit bezeichnet; Classen et al., 2006). Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen mit zu den häufigsten Ursachen für Krankenhausaufenthalte älterer Menschen. Zudem gehören Krankheiten des Kreislaufsystems bei Frauen und Männern zu den häufigsten Todesursachen (siehe Abbildung 3.3).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 3.3

Anzahl der Todesfälle in Deutschland nach häufigsten Todesursachen und Geschlecht im Jahr 2022 (Statistisches Bundesamt, 2023)



Dabei wird das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung durch das Vorhandensein einer familiären Belastung und durch einen geringen sozioökonomischen Status erhöht. Die bedeutendsten Risikofaktoren sind jedoch das bisherige potenziell gesundheitsschädigende Verhalten einer Person, vor allem Rauchen, fettreiche Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel und Stress (Vögele, 2016). Während das Rauchen mit zunehmendem Alter eher abnimmt, stellt gerade Übergewicht ein gravierendes Problem im höheren Alter dar: So waren 2013 ungefähr 70 % der über 60-jährigen Männer und 57 % der über 60-jährigen Frauen übergewichtig (Statistisches Bundesamt, 2016; siehe auch Kurs 1, Kapitel 8 „Ernährung und Essverhalten“).

Bezogen auf die Gesundheitsförderung und Prävention ergeben sich hieraus insbesondere solche Maßnahmen, die auf die Modifikation dieser verhaltensbedingten Gesundheitsrisiken abzielen (siehe Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention“). Dazu werden beispielsweise Koronarsportgruppen, Ernährungsberatung oder Patientenschulungen (siehe Kurs 1, Kapitel 7 „Patientenschulungen“) angeboten, da eine körperlich aktive Lebensweise und eine ausgewogene Ernährung den Blutdruck regulieren und damit die Wahrscheinlichkeit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung senken können (Saß et al., 2009; Vögele, 2016).

Verletzungen durch Stürze

Die Funktionsfähigkeit des Bewegungsapparats unterliegt mit steigendem Alter immer stärkeren Einschränkungen. Dies wird zum Teil durch körperliche Veränderungen und Krankheiten wie Knochenschwund (Osteoporose), Gelenkverschleiß (Arthrose) vor allem in den Hüft- und Kniegelenken oder durch rheumatoide Arthritis bedingt. Dabei lösen diese, zu den

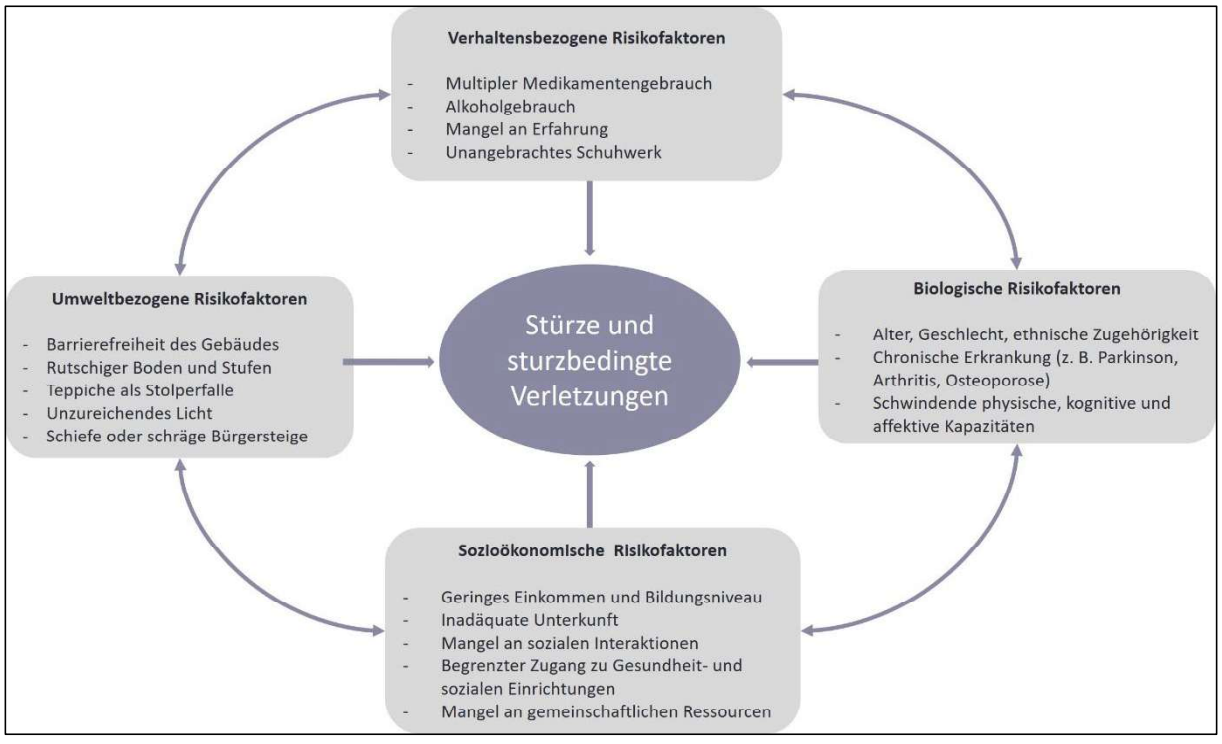
Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

muskuloskelettalen Erkrankungen (d. h. entzündliche und degenerative Erkrankungen des Bewegungsapparats) zählenden, Erscheinungen einerseits Schmerzen aus und schränken andererseits die Beweglichkeit und Belastbarkeit ein, was zu erheblichen Minderungen in der Lebensqualität führen kann (Saß et al., 2009). Ebenso können diese Einschränkungen Stürze begünstigen, die im höheren Alter gravierende Auswirkungen haben können (siehe auch Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention").

In Bezug auf die Sturzgefährdung und die möglichen Folgen eines Sturzes stellen die Einschränkungen des Bewegungsapparats grundsätzlich einen Risikofaktor für Stürze dar, und zusätzlich ist das Frakturrisiko generell bei vielen muskuloskelettalen Erkrankungen erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, einen Sturz zu erleiden, steigt mit dem Alter deutlich an. Während in der Gruppe der 65- bis 70-Jährigen 28-35 % Stürze erlitten haben, sind es bei den über 70-Jährigen bereits 32-42 % (WHO, 2007). Auch das Verletzungsrisiko bei einem Sturz nimmt mit dem Alter zu. Während Stürze im Allgemeinen nur in 5 % der Fälle zu einem Bruch führen, erhöht sich diese Zahl bei über 75-Jährigen, die in der Langzeitpflege betreut werden, auf 10 bis 25 %. Auch berichtet rund ein Drittel aller gestürzten älteren Personen eine dauerhafte Verringerung des Funktionsniveaus nach einem Sturz. Zudem ist durch die Art des Fallens bei den über 75-Jährigen eher die Hüfte betroffen, während bei den 65- bis 70-Jährigen überwiegend das Handgelenk gefährdet ist (Rubenstein, 2006). Weitere Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 1 % der 65-Jährigen eine Fraktur des Oberschenkelknochens erleiden und 35 % der älteren Personen, die wegen eines Sturzes stationär behandelt werden mussten, innerhalb eines Jahres versterben (Saß et al., 2009). Stürze können darüber hinaus auch schwerwiegende psychische Folgen haben, wie etwa die Angst vor einem erneuten Sturz. Dies kann langfristig zu einem Verlust von Selbstwirksamkeitserwartungen, Selbstvertrauen, Aktivitätsvermeidung und Einschränkungen bei sozialen Interaktionen führen (Scheffer et al., 2008). Um gezielte Präventionsmaßnahmen ableiten zu können, hat die WHO (2007)eine Übersicht der wesentlichen Risikofaktoren für Stürze zusammengestellt (siehe Abbildung 3.4).

Abbildung 3.4

Risikofaktoren für Stürze im höheren Alter. Aus WHO, 2007, S. 5



Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Stürzen und zur Verringerung ihrer Folgen zielen zum einen auf die medizinische Behandlung von muskuloskelettalen Erkrankungen durch beispielsweise die Versorgung mit Kalzium oder Vitamin D ab (Tang et al., 2007). Ebenso kann auch die erfolgreiche Behandlung weiterer Erkrankungen, die zu Schwindel führen und daher sturzbegünstigend sein können (etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen), als Präventionsmaßnahme gelten. Aus demselben Grund sollte bei sehr sturzgefährdeten Personen auf ihre Medikation geachtet werden (z. B. Absetzen von Sedativa). Des Weiteren greifen zur Sturzprophylaxe auch verhältnispräventive Maßnahmen wie die Beseitigung von Barrieren und Gefahren in der räumlichen Umgebung (Close et al., 1999; siehe Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention"). Eine weitere wichtige präventive Maßnahme insbesondere für Menschen im höheren Alter ist Erhaltung der körperlichen Fitness durch entsprechende Übung (siehe Kurs 1, Kapitel 9 „Physische Aktivität"). In Video 3.2 werden die wichtigsten sturzpräventiven Maßnahmen zusammengefasst:

Video 3.2. Falls & Fall Prevention in the Elderly and Disabled (The First Aid Show, Keith Sleightholm). Verfügbar unter https://youtu.be/p25uD-lqbCU

3.5.2 Spezifische psychische Belastungen des höheren Alters

Neben den körperlichen Beeinträchtigungen kann auch die psychische Belastung im Alter deutlich erhöht sein. So leidet ungefähr ein Viertel der über 65-jährigen Personen an einer psychischen Störung. Die in dieser Lebensphase bedeutsamsten psychischen Störungen und Erkrankungen sind demenzielle Erkrankungen und Depressionen (Saß et al., 2009).

Demenzielle Erkrankungen

Bei Demenz handelt es sich um ein Syndrom, das durch verschiedene, meist degenerative Prozesse im Gehirn ausgelöst werden kann und höhere kortikale Funktionen beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigungen betreffen hauptsächlich Gedächtnisprozesse (insb. das Kurzzeitgedächtnis), Denken, Orientierung, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen. Begleitet werden diese Veränderungen häufig von Veränderungen der emotionalen Kontrolle und des Sozialverhaltens; es können zudem Veränderungen in der Affektivität und der Persönlichkeit auftreten. Weitere Begleiterscheinungen demenzieller Veränderungen sind vor allem psychischer Natur und umfassen Depressionen, Schlafstörungen, Unruhe, Angst, Aggressionen sowie auch Wahnvorstellungen. Die häufigste Demenzerkrankung (mit ca. 60 bis 70 % der Erkrankungen) ist die Alzheimer-Demenz (Weyerer, 2005). Zu den Symptomen, die auf eine beginnende Alzheimer-Erkrankung hinweisen, gehören typischerweise: Störungen des Gedächtnisses (z. B. Vergessen von kürzlich erlebten Episoden), Probleme bei Tätigkeiten im Haushalt, Sprachschwierigkeiten (z. B. Wortfindungsstörungen), örtliche und zeitliche Orientierungsprobleme (auch in gewohnter Umgebung), Verlust von Fähigkeiten (z. B. Schreiben und Zeichnen), reduziertes Entscheidungsvermögen (z. B. bei Kleidungswahl), Schwierigkeiten im abstrakten Denken (z. B. bei dem Gebrauch von Sprichwörtern), Verlegen von Dingen sowie Schwankungen in der Emotionalität (Brinkmann, 2021). Die Häufigkeit demenzieller Erkrankungen nimmt mit dem Alter sehr stark zu. Während bei 65- bis 69-Jährigen ein Risiko von unter 2 % zur Entwicklung einer demenziellen Erkrankung besteht, steigt das Risiko bei den über 90-Jährigen auf über 50 %. Die Tatsache, dass zwei Drittel aller Demenzerkrankten Frauen sind, ist dabei größtenteils auf die höhere Lebenserwartung von Frauen zurückzuführen (Weyerer, 2005).

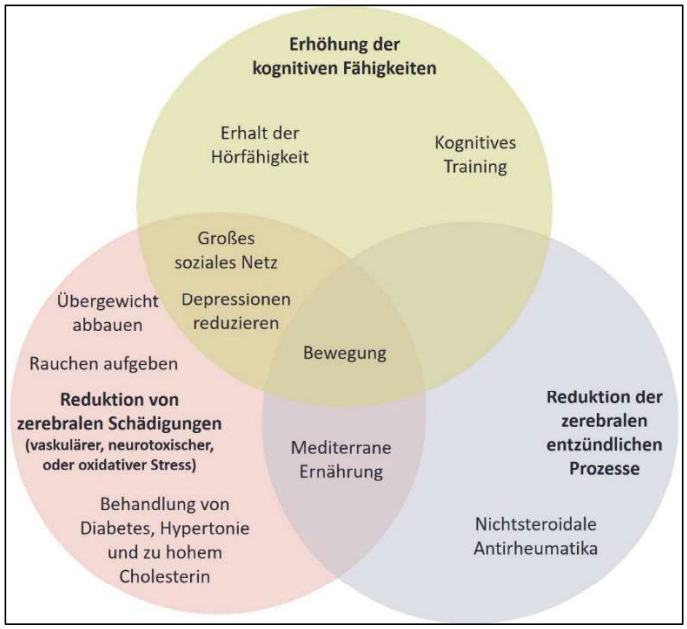
Aufgrund der gesteigerten Lebenserwartung ist die Prävention von Demenzerkrankungen und ihren Folgen ein wichtiges Thema in der Gesundheitsversorgung. Präventionsmaßnahmen

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

können sich auf sehr unterschiedliche Bereiche beziehen. Livingston et al. (2017) unterscheiden dabei Ansätze zur Erhöhung der kognitiven Fähigkeiten und solche, die schwerpunktmäßig auf die Reduktion zerebraler Schädigungen oder auf die Verminderung entzündlicher Prozesse in zerebralen Bereichen abzielen. Abbildung 3.5 zeigt die Zuordnung verschiedener, empirisch nachgewiesen wirksamer Präventionsansätze und Schutzfaktoren zu diesen unterschiedlichen Wirkmechanismen.

Abbildung 3.5

Ansätze zur Prävention von Demenz. Nach Livingston et al., 2017, S.16



Depressionen

Depression ist ein facettenreiches Störungsbild, das sich unter anderem in gedrückter Stimmung, Grübeln und vermindertem Antrieb manifestiert. Depressionen können unterschiedlich stark ausgeprägt sein; das Spektrum erstreckt sich von länger anhaltenden negativen Verstimmungen (Dysthymien) bis hin zu schwerer Niedergeschlagenheit mit vollständigem Antriebsverlust (Major Depression). Bei depressiven Patient:innen im Alter ab 65 Jahren wird häufig auch von Altersdepression gesprochen. Es ist jedoch nicht immer eindeutig zu unterscheiden, ob die ersten Zeichen einer möglichen Depression, wie sozialer Rückzug oder Interessensverlust, Ausdruck genereller Alterserscheinungen oder der Beginn einer klinischen Störung sind. Das Risiko, an einer Erkrankung aus dem Depressionsspektrum zu leiden, verdoppelt sich bei den 70- bis 85-Jährigen. Ebenso steigt das Suizidrisiko, häufig eine Folge von Depressionen, ab 75 Jahren deutlich an und verdreifacht sich ab dem 80. Lebensjahr im Vergleich zu dem des mittleren Erwachsenenalters, insbesondere bei Personen, die an einer weiteren chronischen Erkrankung leiden (Alexopoulos, 2005). Video 3.3 illustriert die Erscheinungsformen, Diagnostik und Behandlung von Depressionen bei Menschen im höheren Lebensalter.

Video 3.3. Depression in older people (Royal College of Psychiatrists). Verfügbar unter https://youtu.be/mrqgaLnQ5zQ

Das Risiko, eine Depression zu entwickeln, wird besonders durch das abnehmende allgemeine Funktionsniveau und auch durch das zunehmende Erleben von Einsamkeit im höheren Alter deutlich gesteigert. Der Zusammenhang von Einsamkeit, Gesundheit und Mortalität im höheren

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Alter wurde von Luo et al. (2012) in einer auf sechs Jahre angelegten Längsschnittstudie an über 2,000 Personen, die das 50. Lebensjahr überschritten hatten, untersucht. Dabei war das Erleben von Einsamkeit mit einem höheren Mortalitätsrisiko über die sechs Jahre verbunden. Interessanterweise konnte dieser Effekt nicht durch die tatsächlichen sozialen Beziehungen oder das Gesundheitsverhalten erklärt werden (siehe Video 3.4 und Kurs 1, Kapitel 3 „Soziale Integration und soziale Unterstützung").

Video 3.4. Loneliness linked to serious health problems and death among elderly (University of California San Francisco). Verfügbar unter https://youtu.be/0MW2inrniZQ

Weiterhin wurden im höheren Lebensalter vielfältige Zusammenhänge zwischen kognitiven Beeinträchtigungen und Depressivität beobachtet. Diese Bezüge werden in der Forschung aus drei Perspektiven erklärt. So beschäftigt sich eine Forschungsrichtung mit den Einflüssen von Depression auf den Beginn und Verlauf kognitiver Beeinträchtigungen. Ein zweiter Zugang betrachtet Depression schwerpunktmäßig als Nebendiagnose beziehungsweise Begleiterscheinung kognitiver Beeinträchtigungen. Schließlich kann aus einer dritten Perspektive der Beginn einer demenziellen Erkrankung selbst eine psychische Belastung darstellen, in deren Folge sich eine depressive Symptomatik entwickelt. Diese drei Betrachtungsweisen ergänzen einander; dementsprechend konnten in verschiedenen Studien unterstützende Ergebnisse für alle drei Ansätze gefunden werden (Gao et al., 2013; Rupprecht & Lang, 2013; Zhang et al., 2012).

Die Stärkung der Selbstwirksamkeit und die Förderung der Akzeptanz altersbedingter Einschränkungen haben sich in der therapeutischen Unterstützung gerade auch bei denjenigen älteren Menschen bewährt, bei denen Depressionen in Kombination mit einer weiteren chronischen Erkrankung auftreten. So konnten ein Rückgang von Depressionen, Angst, Schmerzen und Schlafstörungen bei älteren Menschen mit Depressionen und einer weiteren chronischen Erkrankung durch Entspannungstechniken, kognitive Restrukturierung, Problemlösetraining, Verhaltenstraining bei Insomnie, Ernährung und Bewegung sowie Kommunikationstraining erzielt werden (Rybarczyk et al., 1999).

Literaturverzeichnis

Alexopoulos, G. S. (2005). Depression in the elderly. *The Lancet*, *365*(9475), 1961–1970. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66665-2

Altgeld, T. (2009). Gemeindenahe Gesundheitsförderung für ältere Menschen. *Prävention und Gesundheitsförderung*, *4*(3), 149–157. https://doi.org/10.1007/s11553-009-0185-x

Anisman, H. (2014). *An introduction to stress & health*. Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781473920781

Atchley, R. C. (1989). A continuity theory of normal aging. *The Gerontologist*, *29*(2), 183–190. https://doi.org/10.1093/geront/29.2.183

Baltes, P. B. & Baltes, M. M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In M. M. Baltes & P. B. Baltes (Hrsg.), *Successful aging: Perspectives of the behavioral sciences* (S. 1–34). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511665684.003

Baltes, P. B. & Smith, J. (2003). New frontiers in the future of aging: From successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age. *Gerontology*, *49*(2), 123–135. https://doi.org/10.1159/000067946

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440